

ΟΞΕΙΑ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ

Γενικά: Η οξεία βρογχιολίτιδα είναι αρκετά συχνή λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, ιδίως στα παιδιά κάτω των 2 ετών. Η μέγιστη επίπτωση της νόσου είναι μεταξύ 3 και 9 μηνών, ενώ πάνω από το 90% των εισαγωγών είναι βρέφη μικρότερα του ενός έτους. Τα περισσότερα περιστατικά βρογχιολίτιδας εμφανίζονται ανάμεσα στο Νοέμβριο και τον Απρίλιο, αν και υπάρχουν βρέφη που νοσούν και άλλους μήνες, αναλόγως πάντα με τον ιό που προκαλεί τη νόσηση και φυσικά τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού.

Είναι νόσημα ιογενούς αιτιολογίας, με συνήθη υπαίτιο τον συγκυτιακό ιό RSV (80%), αλλά και ιούς, όπως: h-MPV, ινφλουένζας (*type A & B*), παραϊνφλουένζας και αδενοϊούς. Κύρια παθοφυσιολογική διαταραχή είναι το οίδημα του βρογχικού δέντρου με συσσώρευση βλέννης και ινικής στον αυλό, που προκαλούν μερική ή ολική απόφραξη των βρογχολίων.

Κλινική εικόνα: Η οξεία βρογχιολίτιδα μπορεί να συνοδεύεται από ποικίλα συμπτώματα:

- Πρόδρομα συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό 2-3 ημέρες προ της πνευμονικής νόσου, με πυρετό, ρινική συμφόρηση και καταρροή (κόρυζα), πταρμό και ήπιο βήχα.
- Σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας και απόφραξης των περιφερικών αεραγωγών με βήχα, ταχύπνοια, ταχυκαρδία, διάχυτους λεπτούς εισπνευστικούς τρίζοντες ή/και συρίττοντες ήχους, με παράταση της εκπνοής και εκπνευστικό συριγμό, εισολκές των μεσοπλευρίων διαστημάτων και της σφαγής και σύσπαση κοιλιακών μυών κατά την εκπνοή.
- Συνοδά ευρήματα, όπως ανησυχία, μειωμένη λήψη τροφής και υγρών, λήθαργος, πυρετός 38-39 °C ή υποθερμία ιδίως σε βρέφη μικρότερα του ενός μηνός.
- Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζεται υποξαιμία και οξέωση, κυάνωση, εξάντληση λόγω αυξημένου αναπνευστικού έργου. Άπνοια (διακοπή της αναπνοής > 15-20 δευτερόλεπτα) μπορεί να είναι το πρώτο σύμπτωμα βαριάς βρογχιολίτιδας σε ένα βρέφος και μπορεί να εμφανισθεί κυρίως στην RSV λοίμωξη και συχνά στα βρέφη που γεννιούνται πρόωρα και στα βρέφη που είναι μικρότερα των 3 μηνών και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Υπάρχουν ομάδες παιδιών που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου για την πιθανότητα εμφάνισης σοβαρότερων συμπτωμάτων στην πορεία μιας οξείας βρογχιολίτιδας (βρέφη με ιστορικό προωρότητας, ιστορικό καρδιοπάθειας ή πνευμονοπάθειας, ανοσοανεπάρκεια, κυστική ίνωση, σοβαρή νευρολογική πάθηση, συγγενή ανωμαλία ή τρισωμία), ωστόσο και υγιή βρέφη, χωρίς παράγοντες κινδύνου, μπορεί να εμφανίσουν βαριά βρογχιολίτιδα.

Διαφορική διάγνωση: Πρέπει να διακρίνεται από την παρόξυνση βρογχικού άσθματος, τον ιογενή βρογχόσπασμο, την ιογενή πνευμονία, την άτυπη πνευμονία από Χλαμύδια, την κυστική ίνωση, την εισρόφηση ξένου σώματος και την έμφραξη στο ανώτερο αναπνευστικό, την εισρόφηση, την τραχειομαλάκυνση και άλλες συγγενείς πνευμονοπάθειες και συγγενείς καρδιοπάθειες, τη μάζα του μεσοθωρακίου, τη σοβαρή μεταβολική οξέωση, κ.ά.

Παρακλινικά: Η διάγνωση της οξείας βρογχιολίτιδας είναι κλινική. Παρόλα αυτά, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα – και αφού έχει ολοκληρωθεί η κλινική εξέταση – διενεργούμε γενική αίματος και ελέγχουμε τους δείκτες λοίμωξης (CRP, TKE). Πιθανώς σε βαριές περιπτώσεις με υποξαιμία και οξέωση να χρειαστούν και αέρια αίματος, ένας αδρός βιοχημικός έλεγχος (*Glu, Urea, Creat., AST/ALT, γ-GT, LDH, K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, κ.λπ.*) και γενική εξέταση ούρων.

Η ακτινογραφία θώρακος συνιστάται μόνο σε σοβαρές ή άτυπες εκδηλώσεις ή σε νεογνά και βρέφη με υποκείμενη νόσο ή αν υποψιαζόμαστε κάποια επιπλοκή και όχι ως ρουτίνα. Τα ακτινολογικά ευρήματα είναι υπερδιάταση πνευμόνων, περιβρογχική διήθηση, ατελεκτασία, ενώ στο 10% των περιπτώσεων η ακτινογραφία θώρακος είναι φυσιολογική.

Το άμεσο διαγνωστικό τεστ για RSV σε έτοιμο kit του εμπορίου (με ευαισθησία: 90% και ειδικότητα: 100%) είναι μια ταχεία εξέταση για την ποιοτική ανίχνευση RSV αντιγόνων στα ανθρώπινα ρινοφαρυγγικά δείγματα ή σε ορό ή πλάσμα, με σκοπό τη διάγνωση της RSV βρογχιολίτιδας και μπορεί να εκτελεστεί άμεσα και γρήγορα (εντός 10 λεπτών) στο ΤΕΠ ή στη MBN, βοηθώντας στη διάγνωση και στην περαιτέρω αντιμετώπιση της νόσου.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Η θεραπεία της βρογχιολίτιδας, είναι κυρίως υποστηρικτική. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει οριστική αντι-ική θεραπεία για τις περισσότερες αιτίες βρογχιολίτιδας, για αυτό και η αντιμετώπιση των πασχόντων βρεφών πρέπει να κατευθύνεται προς τη συμπτωματική ανακούφιση και τη διατήρηση επαρκούς ενυδάτωσης και οξυγόνωσης.
2. Ελέγχουμε το σφυγμό, τις αναπνοές, το SpO₂ με παλμική οξυμετρία και τη θερμοκρασία. Εφόσον, ο ασθενής είναι ηλικίας > 3 μηνών, αν οι αναπνοές είναι RR < 50/min και ο κορεσμός SpO₂ > 95%, εάν η σίτιση και η ενυδάτωση είναι αμφοτέρως επαρκείς, ενώ δεν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου και το επίπεδο της οικογένειας είναι ικανοποιητικό, τότε ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπισθεί με ολιγόωρη παραμονή στο ΤΕΠ ή στη MBN. Το βρέφος, παρόλα αυτά, χρειάζεται συνεχή επιτήρηση, ώστε να ανιχνευθούν έγκαιρα όποια σημεία κλινικής επιδείνωσης (άπνοια, αναπνευστική δυσχέρεια, υποξία, ταχύπνοια κ.ά.).
3. Στις περιπτώσεις εκείνες που παρατηρείται κορεσμός SpO₂ < 92%, χορηγούμε οξυγόνο με δροσερούς υδρατμούς, με απλή παιδιατρική προσωπίδα (μάσκα οξυγόνου) ή με ρινική κάνουλα και ήπια αναρρόφηση των εκκρίσεων με σωλήνες Nelaton μικρής διαμέτρου. Παρόλα αυτά, η βαθιά αναρρόφηση μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση στον μικρό ασθενή μας, αλλά έχει συσχετισθεί με μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας.
4. Τοποθετούμε φλεβική γραμμή (24 G) για τη χορήγηση υγρών και την επίτευξη επαρκούς ενυδάτωσης. Χορηγούμε 250-1000 ml D/W 4% - NaCl 0,18%, αναλόγως των αναγκών.
5. Για τον υψηλό πυρετό χορηγούμε Παρακεταμόλη (Depon/Panadol: 10-15 mg/kg/δόση) ή Μεφαιναμικό οξύ (Ponstan/Vidan: 5 mg/kg/δόση) ή αμφότερα εναλλάξ ανά 4-6 ώρες.
6. Χορήγηση εισπνεόμενου β₂ διεγέρτη (Σαλβουταμόλη - *Aerolin*) ή Ιπρατρόπιου (*Atrovent*) δεν έχει τεκμηριωμένη θεραπευτική ένδειξη στην οξεία βρογχιολίτιδα. Σε επιλεγμένα όμως περιστατικά, όπως σε βρέφη ηλικίας > 6-9 μηνών ή σε βρέφη με ιστορικό εκζέματος ή ατοπίας, χορηγούνται εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά σε νεφελοποίηση με O₂ σε ροές περί τα 4-8 lt/min, παρ' όλο που η αγωγή αυτή δεν υποστηρίζεται ως θεραπεία ρουτίνας.
 - ♦ 1 amp. Berovent / Demoren (*Aerolin* + *Atrovent*), σε συσκευή νεφελοποίησης.
7. Ο υπέρτονος φυσιολογικός ορός (1-3 ml NaCl 15%) στη συσκευή νεφελοποίησης μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της βρογχιολίτιδας, όταν η διάρκεια της παραμονής στην κλινική αναμένεται να υπερβεί τις 3 ημέρες, αλλά δεν έχει επίσημη ένδειξη για το ΤΕΠ.
8. Παρά τον σημαντικό ρόλο που παίζει η φλεγμονή στην παθογένεση της απόφραξης των αεραγωγών, μεγάλες πολυκεντρικές δοκιμές κορτικοστεροειδών (εισπνεόμενα ή per os) απέτυχαν να αποδείξουν σημαντικό όφελος στη βελτίωση της κλινικής κατάστασης των ασθενών με οξεία βρογχιολίτιδα και δεν προτείνονται στη θεραπεία.
9. Ο κίνδυνος σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης, ειδικά σε βρέφη ηλικίας 30-90 ημερών με βρογχιολίτιδα, είναι χαμηλός. Τα αντιβιοτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ και μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης συνύπαρξης βακτηριακής λοίμωξης.
10. Η ρινική συμφόρηση και η καταρροή μπορούν να αντιμετωπιστούν με ρινικές πλύσεις με φυσιολογικό ορό ή παρόμοια διαλύματα του εμπορίου, 2-4 φορές την ημέρα.
11. Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες οδηγίες, δεν έχει αποδειχθεί η χρησιμότητα της χορήγησης Αδρεναλίνης στη συσκευή νεφελοποίησης, όπως επίσης και της χορήγησης Ριμπαβιρίνης ως αντικού και γι' αυτό δεν έχουν θέση στη θεραπεία της βρογχιολίτιδας.
12. Ο χρόνος επιστροφής στο σπίτι εξαρτάται αν και τα περισσότερα βρέφη δείχνουν σημεία σημαντικής βελτίωσης μέσα στις επόμενες 2-4 ημέρες από την είσοδό τους στην κλινική. Τα βρέφη σταδιακά βελτιώνονται στις επόμενες 4-7 ημέρες, με υποχώρηση του πυρετού και της αναπνευστικής δυσχέρειας, ενώ ο βήχας και η θορυβώδης αναπνοή, αν και σαφώς βελτιούμενα, μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Σημείωση: Η φυσική μόλυνση με τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) δεν επάγει προστατευτική ανοσία κι έτσι οι άνθρωποι μπορεί να μολυνθούν και να νοσήσουν πολλές φορές.